

CAPÍTULO 13.61

Sinusitis

PERFIL EUNACOM 5.01.1.011

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **rinitis alérgica** es una de las patologías respiratorias más frecuentes en la práctica clínica y un motivo de consulta habitual tanto en atención primaria como en urgencias. Su manejo adecuado impacta significativamente en la calidad de vida del paciente y en el control de otras patologías asociadas como el **Asma Bronquial**.

Diagnóstico: Un enfoque clínico

- El diagnóstico de la rinitis alérgica es **absolutamente clínico**. Se basa en la anamnesis y el examen físico, identificando la tríada clásica o síntomas asociados:
- Rinorrea** acuosa (hialina).
- Estornudos** en salva.
- Prurito** nasal, ocular o faríngeo.
- Obstrucción nasal** (congestión).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

No es necesario solicitar exámenes complementarios (como radiografías de cavidades paranasales o niveles de IgE sérica) para confirmar el diagnóstico de rinitis alérgica. La clínica manda.

El rol del Prick Test (Test Cutáneo)

Aunque el diagnóstico es clínico, el **Prick Test** (test de hipersensibilidad cutánea) tiene utilidades específicas en el manejo a largo plazo:

- Identificación del alérgeno:** Permite al paciente conocer qué gatilla su sintomatología (polen, ácaros, epitelio de animales como el gato, hongos). Esto es vital para las medidas de **evitación ambiental**.
- Diagnóstico diferencial:** Es fundamental para distinguir entre una rinitis alérgica y una **rinitis no alérgica**.
- Pronóstico:** Si un paciente no está dispuesto a alejarse de su mascota (ej. un gato) a pesar de un test positivo, debe entender que su patología será difícil de controlar completamente.

Tratamiento Farmacológico

El pilar del tratamiento se basa en dos grupos de fármacos: los antihistamínicos y los corticoides tópicos.

1. Antihistamínicos H1 de Segunda Generación

Son la primera línea para síntomas leves a moderados, especialmente cuando predomina el prurito y los estornudos.

TABLA 13.61.1: FÁRMACO VS GENERACIÓN

FÁRMACO	GENERACIÓN	VENTAJAS
Loratadina	2da	Barata, genérico accesible, no sedante.
Desloratadina	2da	Metabolito activo, mayor potencia.
Cetirizina	2da	Acción rápida, puede dar leve somnolencia en pocos casos.
Levocetirizina	2da	Alta afinidad por receptor, dosis diaria única.
Fexofenadina	2da	Perfil de seguridad excelente, no sedante.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

¡Cuidado con las confusiones! – No usar 1ra generación: Fármacos como la clorfenamina atraviesan la barrera hematoencefálica y causan sedación importante y efectos anticolinérgicos. – **No confundir receptores:** Los **Anti-H1** (para rinitis) son distintos a los **Anti-H2** (como Ranitidina o Famotidina), que actúan a nivel gástrico y ya no se utilizan de forma estándar en reflujo.

2. Corticoides Tópicos Nasales

Son los fármacos **más efectivos** para el tratamiento de la rinitis alérgica, superando en eficacia a los antihistamínicos en casi todos los síntomas.

- Fármacos comunes:** Fluticasona, Mometasona, Budesonida.
- Elección inicial en:**
 - Cuadros graves o muy sintomáticos.
 - Pacientes con **predominio de obstrucción nasal** (el corticoide es mucho más potente para desinflamar la mucosa que el antihistamínico).

3. Corticoides Orales y Casos Especiales

El uso de corticoides sistémicos (como la **Prednisona**) se reserva para situaciones muy puntuales: 1. **Casos refractarios:** Cuadros demasiado graves que no responden al tratamiento combinado de antihistamínicos y corticoides tópicos. 2. **Poliposis Nasal:** Cuando el paciente presenta **Pólipos Nasales**, estos bloquean físicamente el paso del spray nasal. En estos casos, se inicia con un ciclo corto de corticoide oral para "abrir camino" y permitir que posteriormente el tratamiento tópico llegue a la mucosa.

Algoritmo de Manejo Inicial

- Evaluar severidad y síntoma predominante:**
 - Si es leve/intermitente: Iniciar con **Antihistamínicos H1 de 2da generación**.
 - Si es moderada-grave o muy obstructiva: Iniciar con **Corticoides Tópicos**.
- Escalamiento:** Si no hay control con monoterapia, se deben combinar ambos (Antihistamínico + Corticoide Tópico).
- Evaluación de respuesta:** Si a pesar del tratamiento óptimo persiste la sintomatología, considerar derivación a especialista para evaluar inmunoterapia o descartar complicaciones.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: La rinitis alérgica es una reacción de hipersensibilidad tipo I mediada por IgE. Tras la exposición al alérgeno, ocurre una degranulación de mastocitos que libera histamina (fase temprana) y posteriormente una infiltración de eosinófilos y otras células (fase tardía), que es la responsable de la inflamación crónica y la obstrucción persistente. Por esto, los corticoides son más efectivos en la fase tardía/obstructiva.

Rinitis No Alérgica

Es un grupo de patologías que simulan una rinitis alérgica pero sin mediación inmunológica por IgE.

- Diagnóstico:** Es un **diagnóstico de descarte**.
- Requisitos:**
 - Clínica de rinitis (habitualmente más rinorrea y congestión que prurito/estornudos).
 - Prick Test negativo** (fundamental para descartar el componente alérgico).
- Tipos comunes:** Rinitis vasomotora (reacción a cambios de temperatura o olores fuertes), rinitis medicamentosa (por abuso de descongestionantes tópicos como oximetazolina), y rinitis senil.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, si te presentan un paciente con síntomas de rinitis pero con un Test Cutáneo (Prick Test) negativo, la respuesta correcta suele ser **Rinitis No Alérgica** (o Vasomotora).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Un paciente de 35 años consulta por congestión nasal, presión facial que aumenta al agacharse y rinorrea de 5 días de evolución, asociado a tos y odinofagia leve. No presenta fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el manejo adecuado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Sinusitis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Diagnóstico de sinusitis es clínico: presión facial, rinorrea, obstrucción nasal, hiposmia; pus en meato medio es casi patognomónico
- Clasificación: aguda (<4 semanas), subaguda (4-12 semanas), crónica (>12 semanas)
- Sinusitis aguda viral: <7 días o >7 días pero mejorando; tratamiento sintomático
- Sinusitis aguda bacteriana: >10 días sin mejoría, empeoramiento tras mejoría, pus en meato medio, complicaciones
- Antibiótico de elección en aguda: amoxicilina; alternativa: amoxicilina-ácido clavulánico
- Sinusitis crónica no infecciosa: corticoide tópico + suero fisiológico nasal
- Sinusitis crónica bacteriana: bacterias diferentes (estafilococo aureo y anaerobios); amoxicilina-ácido clavulánico de elección
- En la crónica siempre pedir TAC y considerar cultivo para focalizar el tratamiento antibiótico
- Cirugía endoscópica nasal es última línea en casos refractarios
- Complicaciones importantes: celulitis preorbitaria, celulitis orbitaria, meningitis, absceso cerebral

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SINUSITIS)**PREGUNTA 1**

Un paciente de 35 años consulta por congestión nasal, presión facial que aumenta al agacharse y rinorrea de 5 días de evolución, asociado a tos y odinofagia leve. No presenta fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el manejo adecuado?

- A)** Sinusitis aguda bacteriana; iniciar amoxicilina por 7 días
- B)** Sinusitis aguda viral; tratamiento sintomático con paracetamol y lavados nasales
- C)** Sinusitis crónica; solicitar TAC de senos paranasales
- D)** Rinitis alérgica; iniciar antihistamínicos de segunda generación
- E)** Sinusitis aguda bacteriana; iniciar amoxicilina-ácido clavulánico

PREGUNTA 2

Un paciente de 42 años consulta por síntomas nasales de 12 días de evolución que inicialmente mejoraban pero hace 3 días empeoraron con aparición de fiebre y rinorrea purulenta. Al examen se observa pus saliendo del meato medio. ¿Cuál es el antibiótico de primera línea?

- A)** Azitromicina por 5 días
- B)** Levofloxacino por 10 días
- C)** Amoxicilina por 7 a 14 días
- D)** Clindamicina por 10 días
- E)** Ceftriaxona intramuscular dosis única

PREGUNTA 3

Una paciente de 50 años consulta por obstrucción nasal persistente y rinorrea escasa no purulenta de 4 meses de evolución. No presenta fiebre ni cefalea. ¿Cuál es el enfrentamiento inicial más adecuado?

- A)** Iniciar amoxicilina-ácido clavulánico empírico por 3 semanas
- B)** Indicar corticoide tópico nasal y lavados con suero fisiológico, solicitar TAC de senos paranasales
- C)** Derivar directamente a cirugía endoscópica nasal
- D)** Tratamiento sintomático con descongestionantes orales y control en 2 semanas
- E)** Iniciar antihistamínicos orales y corticoides orales

RESUMEN: SINUSITIS

Esta clase aborda la sinusitis de forma integral, incluyendo su clasificacion, diagnostico diferencial entre viral y bacteriana, y el manejo segun la temporalidad. Los sintomas clasicos son presion/opresion facial que aumenta al agacharse, rinorrea o descarga posterior, obstruccion nasal, hiposmia/anosmia/cacosmia, y fiebre. La presencia de pus saliendo del meato medio es casi patognomonica. El diagnostico es clinico, complementado con TAC (examen de eleccion) o radiografia solo cuando hay duda diagnostica. La sinusitis se clasifica en aguda (menos de 4 semanas), subaguda (4-12 semanas) y cronica (mas de 12 semanas). En la aguda, la diferencia entre viral y bacteriana se basa en el tiempo: menos de 7 dias se asume viral; mas de 10 dias sin mejoría, empeoramiento tras mejoría inicial, pus en meato medio o complicaciones sugieren causa bacteriana. El tratamiento viral es sintomatico (paracetamol, lavados nasales, descongestionantes); el bacteriano se trata con amoxicilina como primera linea, o amoxicilina-acido clavulanico si hay riesgo de resistencia. En la sinusitis cronica, se diferencia entre infecciosa y no infecciosa. La no infecciosa se maneja con corticoide topico y suero fisiologico; si no responde, se agregan antibioticos. La cronica bacteriana se trata con amoxicilina-acido clavulanico (cubre estafilococo aureo y anaerobios, a diferencia de la aguda). Siempre solicitar TAC y cultivo en la cronica. La cirugía endoscopica nasal es la ultima linea para casos refractarios. Duracion del antibiotico: 1-2 semanas en aguda, 2-3 semanas en cronica.